TARKKAILULÄHETE

Lomake M1

Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä

1. Tutkitun henkilötiedot	Sukunimi Saukko	Aikaisemmat sukunimet
	Etunimet Anu	
	Henkilötunnus 010108A0101	Kotipaikka Turku
	Osoite Kiinamyllynkatu 4	
	Tutkitun tunnistaminen ☐ tuntee ennestään ☒ henkilöllisyys varmistettu virallisesta henkilötodistuksesta (passi tai henkilökortti) ☐ muu tapa, mikä? _____ ☐ tutkittua ei voitu tunnistaa	
Laillisen edustajan tiedot (jos tiedot saatavilla)	Laillinen edustaja on tutkitun ☐ edunvalvoja edunvalvontamääräys koskee ☐ henkilöä koskevia asioita ☐ taloudellisia asioita ☐ huoltaja ☐ muu laillinen edustaja (esim. edunvalvontavaltuutettu, valtuutettu) kuka?_____	
	Nimi	Puhelinnumero
	Osoite	
	☐ Tutkittu on otettu sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan Sosiaalihuollosta vastaava toimielin:_____	
	Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän nimi ja puhelinnumero	
Lähiomaisen / muun läheisen tiedot (jos tiedot saatavilla)	Henkilö on tutkitun ☒ lähiomainen, sukulaisuussuhde? Äiti ☐ muu läheinen, kuka?_____	
	Nimi Sini Saukko	Puhelinnumero 040040040
	Osoite Kiinamyllynkatu 4	

2. **Esitiedot**	Esitiedot mielisairauden tai alle 18-vuotiaan henkilön vakavan mielenterveyden häiriön oireiden alkamisesta ja kehittymisestä sekä aikaisemmista hoitovaiheista 18-vuotias nainen. Ei aiempia psykiatrisia hoitokontakteja. Tulee päivystykseen äitinsä kanssa. Potilas on ollut äidin kertoman mukaan hyvin stressaantunut jo viime syksyn kirjoituksista alkaen ja tilanne on koko ajan pahentunut. Nuori on viettänyt jatkuvasti vähemmän aikaa kavereiden kanssa ja viime aikoina ei ole enää poistunut kotoa. Äiti kertoo, että nuori herää vasta vanhempien tullessa töistä kotiin ja vaikuttaa valvovan ja touhuavan jotain öisin. Esitietojen antaja potilas, Sini Saukko

3. Kliinisessä tutkimuksessa tehdyt havainnot	Tutkimuspäivä 27 / 2 2026 Psyykkinen nykytila Likainen habitus. Äidin ollessa huoneessa ei oikein puhu ja lähinnä katselee ympärilleen. Kahden kesken kohdattuna vastaa jotenkin kysymyksiin. Itsetuhoisista ajatuksista kysyessä vastaa abstraktisti luokkaa, että on "ajatellut linnunrataa" ja sitä "miten se kaikki käy järkeen". Puhuminen hidasta ja unenomaista, pitää välillä pitkiäkin taukoja lauseiden välissä. Vaikuttaa vaipuvan nopeasti omiin ajatuksiinsa. Yhtäkkiä myös nousee ylös ja poistuu huoneesta puhuttelusta huolimatta, mutta palaa kuitenkin pian huoneeseen aulassa odottaneen äitinsä saattamana. Keskusteltu nyt taas molempien läsnäollessa. Potilas sanoo, ettei halua hoitoa ja haluaa takaisin kotiin lukemaan fysiikan kirjoituksiin. Ei vastaa lääkehoitokysymykseen. Nykyinen lääkehoito Ei lääkitystä Somaattiset sairaudet, jotka tulee ottaa huomioon Ei somaattisia sairauksia

4. Perustelut tarkkailuun lähettämiseen	(Kuvailtava, miten kukin mielenterveyslain 8 §:n mukainen arvioitava seikka ilmenee tutkitun kohdalla.) Mielisairaus (8 § 1 mom.) tai alle 18-vuotiaan henkilön vakava mielenterveyden häiriö (8 § 2 mom.) Potilaalla on psykoosiin sopivia oireita: hänen puheessaan on merkittävä vastauslatenssi (negatiivinen oire), asosialiteettia ja hänen puheensa on hajanaista (disorganized speech, positiivinen oire). Vastailee mystisillä metaforilla. Äidin kuvaama yöllinen touhuaminen myös viittaa harha-ajatuksiin ja niiden kanssa tekemisissä oloon. Hän ei usein vaikuta olevan läsnä keskustelussa. Tältä pohjalta hänellä voidaan epäillä olevan psykoosisairaus. Hoidon tarve (vähintään yksi kohta kolmesta perusteltava): - Mielisairauden (8 § 1 mom.) tai sairauden (8 § 2 mom.) olennainen paheneminen Ilman asianmukaista hoitoa tila todennäköisesti pahenee, kuten psykoosisairauksilla on tapana.

	- Oman terveyden tai turvallisuuden vakava vaarantuminen Psykoosipotilaiden itsemurhan riski on koholla ja suurimmillaan erityisesti sairauden alkuvaiheessa. Potilas siis voi tehdä itsemurhan ja vastaileekin itsetuhoisuuskysymyksiin sen kanssa flirttailevasti. - Muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vakava vaarantuminen

Perustelut sille, miksi muut mielenterveyspalvelut ovat soveltumattomia (8 § 1 ja 2 mom.) tai riittämättömiä (8 § 1 mom.)

Avohoito tai vapaaehtoinen osastohoito ei onnistu, koska potilas ei koe olevansa hoidon tarpeessa ja kieltäytyy näistä vaihtoehdoista.

5. Johtopäätökset

Edellä olevan perusteella katson, että tutkittu todennäköisesti täyttää mielenterveyslain 8 §:n edellytykset, koska hän on

1) ☒ mielisairas ja mielisairautensa vuoksi hoidon tarpeessa siten, että (8 § 1 mom.)
☐ alle 18-vuotias ja vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi hoidon tarpeessa siten, että (8 § 2 mom.)

2) hoitoon toimittamatta jättäminen
pahentaisi olennaisesti hänen ☒ mielisairauttaan (vain 8 § 1 mom.) ☐ sairauttaan (vain 8 § 2 mom.)
vaarantaisi vakavasti hänen ☒ terveyttään ☒ turvallisuuttaan
vaarantaisi vakavasti muiden henkilöiden ☐ terveyttä ☐ turvallisuutta

3) ja muut mielenterveyspalvelut ☒ eivät sovellu käytettäväksi (8 § 1 ja 2 mom.)
☐ ovat riittämättömiä (vain 8 § 1 mom.)

6. Päiväys ja allekirjoitus

Toimintavelvollisuus tarkkailulähetteen laatimiseen on terveyskeskuksessa työskentelevällä virkasuhteisella lääkärillä sekä, sairaanhoitopiirin hoitaessa terveyskeskuksen päivystyspalvelut sairaanhoitopiirin palveluksessa olevalla päivystyksessä toimivalla virkasuhteisella lääkärillä. Tarkkailulähetteen voi laatia myös julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa toimiva muu laillistettu lääkäri.

Mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitetut edellytykset tutkitun tahdosta riippumattomaan hoitoon ovat todennäköisesti olemassa, minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan

Päivämäärä
27.2.2026

Paikka
Turku

Tutkimuksen suorittajan allekirjoitus

Tutkimuksen suorittajan työskentelypaikka tutkimuksen tekohetkellä (päivystysyksikkö, osasto tms. yksilöitynä) ja puhelinnumero
xyz

Nimen selvennys, arvo, virka-asema/ammattinimike, yksilöintitunnus ja työpaikka

Ämmä Yksi, lääkäri, 123123, xyz

Tallenna Tulosta Tyhjennä